Sujet n°1 : SDD 121

Spécialité : Médecine d'urgence / neurologie

Date : 26/11/2024
Auteur : Cyril COSSE (DES médecine d'urgence, promotion ECN 2022)
Relecteur(s) : Clément FILLIOL (DES radiologie, ECN 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	Item 340 : accidents vasculaires cérébraux
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 121 : déficit neurologique sensitif et/ou moteur
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Déficit focal chez une patiente de 57 ans

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes médecin aux urgences. Vous recevez Madame DURA âgée de 57 ans accompagnée de son mari pour une faiblesse de la main droite et des céphalées survenus pendant qu'elle faisait ses courses, il y a deux heures.

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :

- Décrire les principaux éléments de l'interrogatoire à demander à la patiente
- Décrire les principaux signes à rechercher à l'examen neurologique
- Décrire les constantes nécessaires dans cette situation
- Demander les examens morphologiques nécessaires en urgence

Vous ne devez pas :

- Initier une prise en charge thérapeutique
- Interpréter un ECG
- Réaliser une biologie

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Antécédents personnels / familiaux	1 pt	☐
2.	Recherche des facteurs de risque cardiovasculaires : au minimum 2 parmi les suivants : - HTA, - tabagisme, - diabète, - hypercholestérolémie, - âge, - sexe masculin, - mort subite ou infarctus du myocarde (IDM) chez un apparenté homme de 1er degré avant 55 ans, ou chez une apparentée femme de 1er degré avant 65 ans	1 pt	☐
3.	Recherche des caractéristiques de la céphalée : au minimum 3 parmi les suivants : - caractère brutal - localisation / douleur unilatérale - trouble de la vision associé / diplopie associée - caractère habituel ou non - évaluation de la douleur (échelle numérique…)	1 pt	☐
4.	Recherche la prise de toxiques : tabac, alcool, drogue	1 pt	☐
5.	Recherche l'état de conscience et de la désorientation avec calcul du score de Glasgow	1 pt	☐
6.	Recherche un déficit moteur ou demain en faisant serrer les mains	1 pt	☐
7.	Recherche la motricité des membres supérieurs droit et gauche	1 pt	☐
8.	Réalise une évaluation ophtalmologique : au minimum 2 éléments parmi : - champ visuel ; - examen oculomoteur ; - recherche d'une paralysie faciale	1 pt	☐
9.	Recherche une hypoesthésie aux membres supérieurs	1 pt	☐
10.	Demande les paramètres vitaux : au minimum 3 parmi Fréquence cardiaque, Pression artérielle, SpO2, Fréquence respiratoire	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

11.	Demande une glycémie capillaire	1 pt	☐
12.	Demande un scanner cérébral sans ET avec injection	1 pt	☐
13.	Demande un doppler des troncs supra-aortiques	1 pt	☐

Communications et attitudes

14.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

15.

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

16.

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**16 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Madame DURA âgée de 57 ans accompagnée de son mari pour une faiblesse de la main droite et des maux de tête survenus pendant qu'elle faisait ses courses il y a deux heures.

Plan de la station ECOS :

Pas de patient simulé.

Identité du patient :

Madame DURA âgée de 57 ans, accompagnée de son mari.

Mode de vie :

Ancienne assistante maternelle, mariée, 2 enfants de 24 et 22 ans.
Toxiques : 10 cigarettes par jour pendant 10 ans, arrêt du tabagisme il y a 20 ans ; pas de consommation d'alcool.
Pas d'allergie connue.

Antécédents personnels :

Dyslipidémie sous statine ; Hypertension artérielle sous trithérapie ; Diabète sous insuline ; Sédentarité ; Hypothyroïdie ; Fibromes utérins.

Antécédents familiaux :

Infarctus du myocarde à 59 ans chez son père ; varices chez sa mère.

Médicaments :

Traitement de fond :

- ATORVASTATINE 10 mg le soir
- IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 300 mg / 25 mg le matin

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

- AMLODIPINE 5 mg le matin
- ABASAGLAR 30 UI le soir
- LEVOTHYROXINE 37,5 mcg le matin
- KARDEGIC 75 mg le midi

Pas de traitement récent

Symptômes positifs :

Pour la douleur :
- si l'étudiant demande si la douleur était brutale : "Oui"
- si l'étudiant demande où se situe la douleur : "elle est au niveau du front à droite"
- si l'étudiant demande si la douleur est unilatérale : "oui elle est à droite"
- si l'étudiant demande l'évaluation de la douleur : "elle est à 5/10"

Pour l'examen clinique, les éléments à fournir :
- Désorientée dans le temps
- N'arrive pas à serrer la main à droite
- Mimer la chute du bras droit lors de la fermeture des yeux mais pas à gauche
- Sensation d'être touché mais ne sait pas où
- Pas de dysarthrie ; langage normal
- Pas de paralysie faciale ; mouvements normaux
- Pas de limitation de l'oculomotricité

Paramètres vitaux :

- FC : 75 bpm
- FR : 16 cycles par minute
- SaO2 : 98% en air ambiant
- TA : 154/89 mmHg
- T° : 36,9 °C
- Glycémie capillaire : 6,8 mmol/L

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)